

Información Paciente

Nombre : Claudina Antonieta Rojas Tapia
Edad : 52a 10m 8d
Dirección : El Dintel N2760

Rut : 11.939.729-4
Fecha Nacto: 10/05/1972
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 0221912
Sexo : Femenino
Teléfono : 9 3575 8853

N° Epicrisis
434162

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Cirugía Sector B - Mediana Compleji
Unidad de Egreso : Pre-Hospitalización

Fecha Ingreso : 14/03/2025 07:37
Fecha Egreso : 18/03/2025 15:03

Días Estadía: 4

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Pielonefritis

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

am: hta, trasplantada renal 2021, 2 episodios de paro cardio-respiratorio por hipokalemia recuperado y arritmias ventriculares, tbc pulmonar tratada
qx: colecistectomía, fav brazo izq y der, lobectomía pulmonar, fractura de tobillo, aseo quirúrgico por quemadura brazo izq, trasplante renal
meds: everolimus 1.5 mg c/12h, tacrolimus 1 mg/d, atv 20 mg/d, prednisona 5 mg/d
alergias: no
tbq: no, oh: no, drogas: no
consulta por cuadro de 1 día de evolución de dolor abdominal difuso, mayor en hemiabdomen derecho. sin vómitos, diarrea, fiebre ni molestias urinarias.

Exámenes de ingreso: bilit 0.91, fa 93, ggt 44, got 56, gpt 39, crea 1.36, bun 23.3, elp 139/4.29/106, ph 7.33, pco2 33.9, hco3 17.8, pcr 67.8, hb 12.1, gb 11.670, plq 191.000, p. coag normales
orina inflamatoria

TAC d ingreso: colección perirrenal en fid y en la pared abdominal anterior ¿postquirúrgica?.
leve ascitis en la pelvis.
atrofia renal bilateral con nefrolitiasis bilateral no obstructiva.

Evaluada imagen
Sin necesidad de puncion
Buena respuesta a ceftriaxona
En condiciones de alta para continuar tratamiento en hospital de día

Diagnóstico de Egreso

INFECCION DE VÍAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO -

Condición de Egreso Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J: NO

Buenas condiciones generales, HDN estable, afebril. Buena tolerancia oral. Manejo analgésico adecuado. Diuresis espontánea.

Fecha Epicrisis : 18/03/2025 15:38

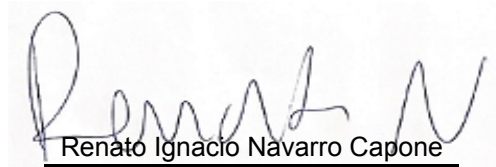
Plan Post Alta

Reposo relativo
Régimen liviano
Hidratación muy abundante
Orinar seguido, no aguantarse la orina
Evitar antiinflamatorios orales
Paracetamol 500 mg: 2 comprimidos cada 8 hrs vía oral por 5 días
Metamizol 300 mg: 1 comprimido cada 8 hrs vía oral por 5 días
Prednisona 15 mg/día vo por 3 días, luego continuar con 5 mg/día via oral a permanencia
Mantener inmunosupresión (1 mg de tacrolimus XL c/24 hrs + 1,5 mg de everolimus c/12 hrs)
Mantener medicamentos habituales
En hospital de día
Ceftriaxona 2 gramos / día EV por 10 días
Control en pasillo 9 CDT con Dr Ortiz en 3 semanas (Solicitar hora en ventanilla con interconsulta y epicrisis).
Consultar en servicio de urgencias en caso de dolor intenso que no cede con analgesia, fiebre, vómitos o mala tolerancia oral, o según estime necesario

Indicaciones

Tipo de Reposo :
Régimen Alimentario :
Medicamentos :

Controles



Renato Ignacio Navarro Capone

INTERNO

Becado/Residente

Médico Tratante (Staff)